

PAULO CESAR L VILLAÇA			
IDADE:	PESO:	ALTURA:	PROFISSÃO:
SINTOMAS:			
QUEIXAS:			
MEDICAMENTOS:			
MÉDICO :			
EXERCÍCIO FÍSICO:			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ :		ALMOÇO:	LANCHE: JANTAR:
HORA QUE DORME :		HORA QUE ACORDA:	
COCHILLO ()SIM ()NÃO		DORME ACOMPANHADO ()SIM ()NÃO ()EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA ()SIM ()X NA SEMANA ()NÃO			
FUMO ()SIM ()MAÇO/DIA ()NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO:		BANHEIRO:	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP:	MALLAMPATI:	IAH:	SPO2:
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:			
CIRURGIAS: ()NASAL ()AMIGDALECTOMIA			
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:			
COMORBIDADE: ()RESPIRATÓRIA ()ENDÓCRINA ()CARDÍACA			
()ORTOPÉDICA ()NEUROLÓGICA ()OUTROS			
08/08 ↓ a pressão p/ 8.0 de 11.4 cm H ₂ O			
23			
07/08 P= 8, cm H ₂ O trocar a másc.			
25 IAH= 10.6 e/lv			
m. de uso: 5h40'			
fuga= 44.2 lpm. Shou.			

Nome: PAULO CESAR LOUZAR VILLAÇA

Data de Nascimento: 25-10-1955

IMC: 31,79

Sexo: Masculino

Data do exame: 03-07-2023

Peso: 103 kg

Altura: 1,80 m

Médico: DR. JOO MI LEE CHO

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 03-07-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 483,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 10,5 e 56,5 minutos. O tempo total de sono foi de 360,5 min, eficiência de 74,6% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,5%; estágio N2: 52,6%; estágio N3: 24,3%; sono REM: 20,7%. O índice de despertares foi de 3,0/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 5,5/hora, sendo 6 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 27 hipopnéias. A SpO2 média foi de 95% e a mínima de 85%, permanecendo 0,9% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 53 - 80 bpm e NREM de 52 - 80 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (12), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N3 do sono NREM aumentada;
3. latência para o sono REM diminuída;
4. número de despertares breves normal;
5. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (4,2/hora);
6. registro de ronco durante o sono.

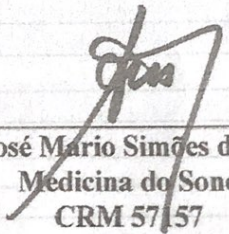
Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 8,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157